

Statusrapport

Perioperativ transkutan elektrisk akupunktstimulering (TEAS) och elektroakupunktur (EA) hos vuxna som genomgår operation under generell anestesi

PROTOKOLL	SÖKNING	SCREENING	NUVARANDE FAS
PROSPERO-registrerat och operationaliserat	4 internationella databaser	Titel/abstrakt slutförd	Fulltextgranskning pågår

1. Syfte och avgränsning

Översikten följer den godkända PROSPERO-registreringen. TEAS och nålbaserad EA behandlas som separata interventioner. Huvudjämförelsen är shamkontroll; sedvanlig vård eller ingen stimulering analyseras separat. Inga språk- eller datumbegränsningar har använts. Generell anestesi verifieras i screeningen i stället för att användas som obligatoriskt sökbegrepp.

2. Genomförd litteratursökning

Sökstrategierna byggdes kring tre huvudblock: EA/TEAS, kirurgi/perioperativ vård samt randomiserade eller kontrollerade studier. Ämnesord och fritext anpassades till varje databas. Nedan anges exporterade råträffar före deduplicering.

Databas	Sökdatum	Exporterade poster	Kommentar
PubMed/MEDLINE	21 juli 2026	1 009	Validerad RIS-export; sentinel recall 24/25 indexerade rapporter.
Embase	22 juli 2026	1 928	Emtree och fritext; randomiseringsfilter; export i fyra batcher.
Cochrane CENTRAL	21-22 juli 2026	1 698	CENTRAL Trials; samtliga fem fördefinierade valideringsstudier återfanns.
CINAHL Ultimate	23 juli 2026	465	Lunds åtkomst gav Ultimate i stället för Complete; inga språk- eller datumfilter.
Totalt före deduplicering		5 100	Databasöverlapp förväntades och hanterades i Covidence.

3. Titel- och abstraktscreening

- Screeningen genomfördes i Covidence med två oberoende granskarbedömningar.
- Den aktiva titel-/abstraktön slutfördes för båda granskarna; 2 941 poster screenades per granskare i det slutliga arbetsflödet.
- Beslut registrerades som Ja, Kanske eller Nej enligt protokollets inklusions- och exklusionskriterier.
- Vanliga exklusionsorsaker var protokoll utan resultat, djurstudier, icke-kirurgiska populationer, avsaknad av generell anestesi, fel intervention, olämplig tidpunkt och icke-randomiserad design.
- Screeningloggar och beslut finns sparade med löpnummer, tidsstämplar och kvalitetskontroller för reproducerbarhet.

4. Pågående fulltextgranskning

Totalt gick 282 referenser vidare till fulltextfasen i det aktuella Covidence-flödet. Per den 11 augusti 2026 hade 209 fulltextbeslut registrerats: 182 inkluderade och 27 exkluderade. Av de granskade posterna är 62 särskilt markerade för mänsklig kontroll, exempelvis vid oklar anestesiform, ålder, behandlingsstart, rapportidentitet eller behov av komplett artikel.

- För varje beslut dokumenteras bibliografisk identitet, design, population, anestesi, intervention, tidpunkt, jämförelsegrupp, utfall och sid-/avsnittsstöd.
- Möjliga följdrapporter och dubletter flaggas för att undvika dubbelräkning av samma studie.
- Exklusion registreras först när en tydlig primär exklusionsorsak kan beläggas.

Åtkomstproblem för kinesiska publikationer

Flera relevanta kinesiska artiklar kan identifieras via abstract och förlagsmetadata, men fulltexten är i vissa fall låst bakom CNKI-inloggning, säkerhetsverifiering eller prenumeration hos kinesiska förlag. Dessa referenser lämnas för manuell hämtning och slutlig bedömning. Lunds universitetsbibliotek kommer att kontaktas om institutionell åtkomst eller fjärrlån. En akademisk kontakt som kan mandarin kan dessutom hjälpa till med läsning och kontroll av kinesiska artiklar.

5. Möjlig roll för ytterligare forskare

En medforskare som ansluter i detta skede kan framför allt bidra med:

- oberoende kontroll av fulltextbedömningar och bedömning av osäkra fall;
- granskning av kinesiska fulltexter eller samarbete med mandarin-kunnig person;
- kontroll av följsamhet till PROSPERO-kriterierna och dokumenterade exklusionsorsaker;
- senare dataextraktion, risk-of-bias-bedömning och sammanställning av TEAS och EA som separata modaliteter.

6. Underlag som finns tillgängligt

- PROSPERO-registreringen och en låst operativ protokollsammanfattning.
- Exakta, databasvisa söksträngar, sökloggar, träffantal och valideringsfiler.
- Reproducerbara RIS-exporter och manifest.
- Fullständiga screeningloggar samt strukturerade fulltextbeslut och listor över poster som kräver mänsklig kontroll.